

認知衰退與失智症
風險降低指南

醫療人員版

快速查找建議強度、證據、適用族群與執行考量

內容定位

依 WHO 2026 英文原文進行的非官方、非營利中文知識轉譯。內容涵蓋指南範圍、方法、20個風險主題、跨主題執行及研究缺口；不能取代英文原文、臨床指引或個別醫療建議。

原文：World Health Organization. Risk reduction of cognitive decline and dementia: WHO guidelines, second edition. Geneva: WHO; 2026. ISBN 978-92-4-012355-7.

版本日期：2026-07-23

透明聲明與使用界線

AI 協作方式

- 本系列使用 OpenAI Codex 協助擷取與比對原文、建立內容架構、產生中文初稿、依受眾改寫、設計網頁及排版 PDF。
- AI 可能產生誤譯、遺漏或過度簡化；內容未經 WHO 審核，也不代表 WHO 立場或背書。
- 若中文整理與英文原文不一致，以 WHO 英文原文及官方最新資訊為準。

醫療與法律聲明

- 本手冊只作知識轉譯、衛教與分享，不構成診斷、治療、用藥或個別醫療建議。
- 原著採 CC BY-NC-SA 3.0 IGO；本中文改作採 CC BY-NC-SA 4.0。不得使用 WHO 標誌或暗示 WHO 背書。
- 若涉及收費、商業廣告、產品背書或第三方圖片／表格，應另行確認權利或向 WHO 申請許可。

醫療人員如何使用

- 先確認未罹患失智症及基線認知狀態，再辨識實際存在的可改變風險。
- 區分失智特定建議與各疾病既有標準照護；證據不足不代表停止治療。
- 條件式建議需納入利益風險、偏好、共病、資源、可接受性與公平性。
- 追蹤不只包含認知測驗，也應納入功能、生活品質、依從性、不良事件與照護負擔。

目錄

透明聲明與使用界線	2
目錄	3
第一部分 指南範圍、方法與讀法	4
這份指南適用於誰	4
如何閱讀建議	4
2026年第二版的重要更新	4
跨主題執行原則	4
WHO如何形成建議	4
20個主題快速索引	5
第二部分 20個主題詳細整理	5
01 認知活動	6
02 社會活動	7
03 身體活動	8
04 減少有害飲酒	9
05 戒菸與避免菸害	10
06 健康均衡飲食與營養補充品	11
07 過重與肥胖	12
08 糖尿病	13
09 高血壓	14
10 血脂異常	15
11 聽力損失	16
12 更年期荷爾蒙治療	17
13 憂鬱症	18
14 中風	19
15 創傷性腦損傷	20
16 視力障礙	21
17 睡眠	22
18 HIV	23
19 空氣污染	24
20 多領域介入	25
第三部分 執行、監測與未來方向	26
跨領域執行重點	26
監測與評估建議	26
整體證據限制	26
資料來源與核對方式	26

第一部分 指南範圍、方法與讀法

這份指南適用於誰

- 適用於尚未罹患失智症的成人，包括認知正常者、輕度認知障礙（MCI）者，以及合併其他健康狀況者。
- 主要提供第一線與第二線醫療照護人員使用，也可供政策制定者、長照與社區服務體系參考。
- 指南聚焦降低未來認知衰退及失智風險，不是失智症診斷、治療或照護指南。

原文定位：執行摘要 x-xi；第1章 6-8。

如何閱讀建議

- 「強烈建議」表示多數情境應採行；「條件式建議」表示需要依個人風險、偏好、資源、可行性與公平性共同決定。
- 證據確定性分為高、中等、低與極低；確定性低不代表介入無效，而是對效果大小仍不確定。
- 「證據不足」只表示目前不能提出失智特定建議；相關疾病仍應依既有 WHO 或所在地臨床指引處理。
- 部分研究以認知測驗變化代替失智發生率，因此短期認知改善不一定等同長期預防失智。

原文定位：第2章 14-16；執行摘要 xi。

2026年第二版的重要更新

- 重新確認5項既有建議，並對8項既有風險因子進行完整證據更新。
- 新增8項過去未納入的風險因子，包括 HIV、中風、創傷性腦損傷、視力、睡眠與空氣污染等。
- 更強調生命歷程：教育、生活環境與健康風險會長期累積；同一風險因子在中年與晚年的意義可能不同。
- 更強調多領域、個別化及人口層級介入，而不是把責任全部放在個人生活選擇。

原文定位：執行摘要 x-xi；第1章 2-8。

跨主題執行原則

- 把介入整合到基層醫療、非傳染性疾病、健康老化、長照及社區服務，避免建立彼此分離的新流程。
- 同時處理費用、交通、語言、數位落差、污名、照顧負荷及服務可近性等結構性障礙。
- 平衡面對面與數位服務，強化工作人員訓練、跨專業合作、公共溝通及轉介。
- 監測可近性、參與率、持續性、不良事件、功能與生活品質；不能只記錄認知測驗分數。

原文定位：第4章 102-105。

WHO如何形成建議

- WHO 指引發展小組使用系統性回顧、GRADE 證據確定性評估及 evidence-to-decision 架構。
- 決策不只看效果，也考量利益與傷害、價值偏好、資源、成本效益、健康公平、可接受性與可行性。
- 2026年第二版確認部分2019年建議，並針對新證據或新增風險因子完成全面證據綜整。
- 多數條件式建議需要共享決策；不同地區可依資源與文化調整執行方式，但不應改變建議本意。

原文定位：第2章，原文印刷頁 9-16。

20個主題快速索引

主題	建議類型	證據	原文頁
認知活動	條件式建議	低／極低	20–24
社會活動	條件式建議	極低	25–28
身體活動	強烈 + 條件式	中等／低	29–31
減少有害飲酒	條件式建議	中等	32–35
戒菸與避免菸害	強烈建議	低	36–38
健康均衡飲食與營養補充品	條件式 + 反對	中等	39–43
過重與肥胖	條件式建議	低至中等	45–48
糖尿病	條件式建議	極低	49–52
高血壓	條件式建議	極低	53–56
血脂異常	條件式建議	低	57–59
聽力損失	條件式建議	低	60–63
更年期荷爾蒙治療	反對建議／證據不足	極低	64–67
憂鬱症	證據不足	—	68–71
中風	證據不足	—	72–75
創傷性腦損傷	證據不足	—	76–79
視力障礙	證據不足	—	80–82
睡眠	證據不足	—	83–86
HIV	證據不足	—	87–90
空氣污染	條件式建議	極低	92–96
多領域介入	條件式建議	中至高	98–101

第二部分 20個主題詳細整理

下列每題依序呈現失智特定建議、受眾行動、WHO通用指引、證據、限制、執行及研究缺口。原文頁碼指紙本印刷頁；PDF檢視器頁碼可能因前置頁不同而有所偏移。

01 認知活動

領域：生活行為

建議：條件式建議

證據：低／極低

原文：20–24

WHO失智特定建議

可鼓勵一般成人參與認知刺激；對認知正常或輕度認知障礙（MCI）的高齡者，可提供認知訓練。

醫療人員版行動重點

先區分正常認知、MCI與失智；本指南適用於未罹失智者。說明可能效益與證據不確定性。

原版摘要如何解讀

認知訓練是針對特定認知領域反覆練習；認知刺激則包括團體活動及閱讀、說故事、遊戲等日常活動。整體效益可能存在，但研究差異大、長期失智發生資料有限。

WHO通用指引與適用範圍

- 從幼兒早期互動、平等教育、持續學習到具認知刺激性的工作與環境，都屬於生命歷程腦健康策略。
- 正式的認知訓練與日常認知刺激不同：前者針對特定認知領域反覆練習；後者包括閱讀、說故事、遊戲、音樂及團體活動。

證據與可能效益

- 認知訓練可能帶來小幅認知改善，但現有研究尚未顯示5年後失智發生率下降。
- 結構化認知刺激可能改善執行功能與語文流暢度；對整體認知、工作記憶及失智發生的效果仍不確定。
- 觀察研究顯示日常認知活動可能與較低失智或MCI風險相關，但容易受到教育、健康與反向因果影響。

限制、風險與容易誤解之處

- 目前無法確定最佳活動種類、頻率、強度或持續時間，也不能把短期測驗進步直接解讀為預防失智。
- 活動應有新穎性與適度挑戰，但不能造成羞辱、挫折或過度負擔。

落實與追蹤方式

- 提供文化、語言與能力相符的低成本選項，並處理交通、行動、費用與數位識能障礙。
- 可透過圖書館、社區中心、基層醫療、長者方案、團體或一對一方式提供；數位工具不能成為唯一管道。

研究缺口

- 仍需要以MCI及失智發生率為結局的長期試驗，以及低中所得國家、不同教育與社經族群的研究。

原文核對：第3章 Recommendations，原文印刷頁 20–24。官方出版頁：<https://www.who.int/publications/i/item/9789240123557>

02 社會活動

領域：生活行為

建議：條件式建議

證據：極低

原文：25–28

WHO失智特定建議

對認知正常或MCI成人，可建議參與社會活動介入，以降低認知衰退及／或失智風險。

醫療人員版行動重點

評估社會孤立與孤獨感；把社會處方與功能、情緒及感官評估連結。

原版摘要如何解讀

社會參與與健康福祉密切相關，但能否直接降低失智風險的介入證據仍很不確定。不可把孤獨完全歸因於個人。

WHO通用指引與適用範圍

- 社會參與與健康、福祉密切相關，應在生命歷程中支持；WHO 同時強調減少孤獨與社會孤立。
- 社會活動介入可包含團體活動、同儕支持、志工、社區參與、社會處方及促進聯繫的數位或面對面服務。

證據與可能效益

- 介入研究可能顯示部分認知或心理社會效益，但直接降低MCI或失智發生的證據極不確定。
- 社會孤立、孤獨與活動不足並非同一概念；人數多不一定代表有支持性的關係。

限制、風險與容易誤解之處

- 不能把孤獨歸咎於個人，也不能強迫不符合偏好、文化或安全需求的社交。
- 聽力、視力、行動、交通、喪偶、語言、貧窮、照顧責任與數位落差都可能形成障礙。

落實與追蹤方式

- 先詢問本人重視的關係與活動，再共同選擇可持續且有意義的參與方式。
- 連結既有社區組織，並同步處理感官、情緒、功能及交通問題。

研究缺口

- 需要更長期、具明確定義的介入研究，區分孤獨、孤立與社會參與，並納入失智發生及公平性結果。

原文核對：第3章 Recommendations，原文印刷頁 25–28。官方出版頁：<https://www.who.int/publications/i/item/9789240123557>

03 身體活動

領域：生活行為

建議：強烈 + 條件式

證據：中等／低

原文：29–31

WHO失智特定建議

認知正常成人應建議身體活動（強烈建議）；MCI成人可建議身體活動（條件式建議）。

醫療人員版行動重點

依WHO身體活動指引與共病狀況開立個別化處方；辨識胸痛、暈厥等需進一步評估的警訊。

原版摘要如何解讀

身體活動同時有心血管、代謝、活動功能與心理健康效益。介入應涵蓋有氧、肌力與減少久坐，並依能力調整。

WHO通用指引與適用範圍

- 所有年齡與能力者都應依 WHO 身體活動及久坐指引，增加有氧活動、肌力活動並減少久坐。
- 對認知正常成人是強烈建議、中等確定性；對MCI成人是條件式建議、低確定性。

證據與可能效益

- 身體活動除可能保護認知外，也有心血管、代謝、活動功能、跌倒預防及心理健康效益。
- 不同研究的活動種類、劑量及追蹤期差異大，對失智發生的直接效果仍比一般健康效益不確定。

限制、風險與容易誤解之處

- 應依體能、共病、疼痛、跌倒風險及個人偏好調整，避免突然增加到無法承受的強度。
- 胸痛、暈厥、明顯呼吸困難或急性神經症狀需要先接受醫療評估。

落實與追蹤方式

- 從可達成的短時段開始，逐步增加；把步行、日常移動、肌力、平衡與減少久坐一起規劃。
- 提供安全場地、輔具與陪伴，並追蹤出席、耐受度、疼痛、跌倒與功能變化。

研究缺口

- 仍需釐清對不同認知狀態最有效的活動組合、劑量、持續時間及長期失智結果。

原文核對：第3章 Recommendations，原文印刷頁 29–31。官方出版頁：<https://www.who.int/publications/i/item/9789240123557>

04 減少有害飲酒

領域：生活行為

建議：條件式建議

證據：中等

原文：32-35

WHO失智特定建議

可對危險或有害飲酒者提供減量或停止飲酒的介入，包括對酒精依賴者的支持。不可為健康效益建議飲酒。

醫療人員版行動重點

進行簡短篩檢與介入，依依賴程度安排戒斷風險評估、藥物與心理社會支持。

原版摘要如何解讀

酒精具有精神活性、毒性及成癮性；減少有害使用的健康效益不限於腦健康。失智預防不能作為開始喝酒的理由。

WHO通用指引與適用範圍

- 酒精具有精神活性、毒性與成癮性；WHO 不建議以任何飲酒量作為健康促進方式。
- 失智特定建議針對危險或有害飲酒者，以及需要依賴治療支持者；不是鼓勵不飲酒者開始喝酒。

證據與可能效益

- 減少或停止危險與有害飲酒可能降低認知衰退及失智風險，證據確定性為中等。
- 戒酒或減量也可降低肝病、癌症、心血管傷害、事故及家庭社會傷害。

限制、風險與容易誤解之處

- 酒精依賴者突然自行停酒可能發生嚴重戒斷、抽搐或譫妄，需要專業評估。
- 需檢視跌倒、營養、睡眠、情緒、用藥交互作用及駕駛風險。

落實與追蹤方式

- 以非批判方式進行簡短篩檢、回饋與共同目標設定；依嚴重度提供心理、藥物及社會支持。
- 建立可快速轉介戒斷處理、成癮醫療及危機服務的流程。

研究缺口

- 需要更清楚的飲酒暴露定義、長期失智結果，以及不同文化與性別族群的介入研究。

原文核對：第3章 Recommendations，原文印刷頁 32-35。官方出版頁：<https://www.who.int/publications/i/item/9789240123557>

05 戒菸與避免菸害

領域：生活行為

建議：強烈建議

證據：低

原文：36–38

WHO失智特定建議

應向使用菸草的成人提供戒菸介入，以降低認知衰退及失智風險。

醫療人員版行動重點

提供行為諮商與合適藥物，追蹤復吸；把戒菸納入慢病及腦健康照護。

原版摘要如何解讀

戒菸的總體效益明確，應結合實證支持，而非只給一句『不要抽』；同時保護所有人免受二手菸。

WHO通用指引與適用範圍

- 菸草應完全避免；所有使用者都應獲得實證行為與藥物戒菸支持，所有人也應免於二手菸暴露。
- 戒菸介入是強烈建議，即使失智特定證據確定性偏低，整體健康利益仍明確。

證據與可能效益

- 持續吸菸與血管、呼吸及多種癌症風險相關；戒菸的總體利益遠超過單一認知結局。
- 只有勸告「不要抽」通常不足，結合諮商、藥物及追蹤可提高成功率。

限制、風險與容易誤解之處

- 評估紙菸、加熱菸、電子煙及其他菸草使用型態，不把替代產品直接視為無害。
- 注意戒斷症狀、情緒變化與復吸，不以一次失敗判定無法戒除。

落實與追蹤方式

- 每次接觸都簡短詢問、建議、評估意願、協助及安排追蹤，並連結戒菸門診或專線。
- 機構及家庭維持無菸環境，照護團隊記錄使用量、觸發情境及用藥反應。

研究缺口

- 需要更多長期認知與失智結局資料，以及不同戒菸模式在資源有限地區的可行性研究。

原文核對：第3章 Recommendations，原文印刷頁 36–38。官方出版頁：<https://www.who.int/publications/i/item/9789240123557>

06 健康均衡飲食與營養補充品

領域：生活行為

建議：條件式 + 反對

證據：中等

原文：39–43

WHO失智特定建議

可向認知正常或MCI成人建議健康均衡飲食；若無已確立的缺乏，不建議為預防認知衰退／失智補充維生素B、E、omega-3或綜合維生素礦物質。

醫療人員版行動重點

評估營養風險與缺乏；對有適應症者治療缺乏，並釐清指南反對的是『專為失智預防的例行補充』。

原版摘要如何解讀

健康飲食需足量、均衡、多樣與適度，並依文化、可近性和個人需求調整。對特定補充品是強烈反對建議，不等同於忽略真正的營養缺乏。

WHO通用指引與適用範圍

- 健康飲食應兼具足量、均衡、多樣及適度，並依個人需求、文化、信念、可取得食物及飲食習慣調整。
- 健康均衡飲食是條件式建議；無已確立缺乏時，例行補充維生素B、E、omega-3或綜合維生素礦物質是強烈反對建議。

證據與可能效益

- 健康飲食型態可能降低認知衰退及失智風險，證據確定性中等；整體飲食型態比單一營養素更重要。
- 反對補充品的建議只適用於沒有確立缺乏者，不影響對真正營養缺乏的診斷與治療。

限制、風險與容易誤解之處

- 不要將特定飲食品牌、昂貴保健品或極端限制飲食宣稱為防失智療法。
- 年長者需注意體重下降、吞嚥、牙口、肌少症、食物取得與藥物交互作用。

落實與追蹤方式

- 優先改善可長期維持的餐食環境與食物取得，使用在地、可負擔且文化合適的原型食物。
- 若有貧血、吸收不良、特殊疾病或疑似缺乏，先評估再個別補充。

研究缺口

- 需要更一致的飲食定義、客觀依從性測量、長期失智結局，以及不同地區飲食文化的研究。

原文核對：第3章 Recommendations，原文印刷頁 39–43。官方出版頁：<https://www.who.int/publications/i/item/9789240123557>

07 過重與肥胖

領域：健康狀況

建議：條件式建議

證據：低至中等

原文：45–48

WHO失智特定建議

可向過重或肥胖成人提供飲食限制介入；可提供降低中年過重或肥胖的介入，以降低認知衰退及／或失智風險。

醫療人員版行動重點

依整體肥胖指引及共病治療；中年風險管理重點高，老年期需排除反向因果與肌少症。

原版摘要如何解讀

中年是重要時窗；晚年體重下降也可能是疾病前驅，不能單靠體重推論風險。介入要兼顧肌肉、營養與污名。

WHO通用指引與適用範圍

- 所有肥胖成人都應依既有指引獲得無污名、以健康為中心的評估與管理。
- 失智特定建議包括降低中年過重／肥胖，以及對過重或肥胖成人提供飲食限制介入；兩者皆為條件式。

證據與可能效益

- 中年過重與肥胖較一致地與後續認知衰退及失智風險相關；證據確定性低至中等。
- 晚年體重下降可能是衰弱、疾病或失智前驅表現，不能把所有晚年減重都視為有益。

限制、風險與容易誤解之處

- 介入需保留肌肉、營養與功能，避免快速減重、過度限制及體重污名。
- 不明原因體重下降、食慾改變或功能惡化需要進一步評估。

落實與追蹤方式

- 結合飲食、活動、睡眠、心理及社會支持，依共病與偏好共同設定可維持的目標。
- 追蹤體重之外，也要觀察腰圍、肌力、營養、功能、生活品質及不良事件。

研究缺口

- 需要釐清不同生命階段、減重方式、肌肉與身體組成對長期認知結果的影響。

原文核對：第3章 Recommendations，原文印刷頁 45–48。官方出版頁：<https://www.who.int/publications/i/item/9789240123557>

08 糖尿病

領域：健康狀況

建議：條件式建議

證據：極低

原文：49–52

WHO失智特定建議

可向糖尿病成人提供糖尿病管理，以降低認知衰退及／或失智風險。

醫療人員版行動重點

個別化血糖目標，避免低血糖；評估認知與自我管理能力，必要時簡化方案。

原版摘要如何解讀

糖尿病本就應依臨床指引治療；額外的失智風險降低證據確定性極低。需在血糖效益、低血糖與照護負擔間平衡。

WHO通用指引與適用範圍

- 所有糖尿病成人都應依 WHO 及所在地糖尿病指引接受診斷、血糖管理、併發症預防與持續照護。
- 為降低認知衰退或失智風險而管理糖尿病屬條件式建議，證據確定性極低。

證據與可能效益

- 糖尿病與血管、代謝及認知風險相關，但特定治療策略能否額外降低失智發生仍不確定。
- 即使失智證據不確定，控制症狀及預防腎臟、眼睛、神經與心血管併發症仍有明確價值。

限制、風險與容易誤解之處

- 過度嚴格控制可能增加低血糖、跌倒與治療負擔，尤其是高齡、衰弱或認知有變化者。
- 需評估用藥、注射、監測、飲食及就醫流程是否超出本人能力。

落實與追蹤方式

- 個別化目標並避免低血糖；必要時簡化方案、使用清楚提示並納入家屬或照護者支持。
- 同步管理血壓、血脂、吸菸、活動與營養，而非只追蹤單一血糖數值。

研究缺口

- 需要比較不同糖尿病治療、低血糖暴露及控制強度對長期認知與失智結果的研究。

原文核對：第3章 Recommendations，原文印刷頁 49–52。官方出版頁：<https://www.who.int/publications/i/item/9789240123557>

09 高血壓

領域：健康狀況

建議：條件式建議

證據：極低

原文：53–56

WHO失智特定建議

可向高血壓成人提供高血壓管理，以降低認知衰退及／或失智風險。

醫療人員版行動重點

依高血壓指引治療並評估直立性低血壓、共病及多重用藥。

原版摘要如何解讀

血壓管理的心腦血管效益明確；對失智結局的額外證據很不確定。需持續、正確量測與處理依從性。

WHO通用指引與適用範圍

- 所有高血壓成人都應依指引接受正確量測、生活介入、藥物治療與追蹤。
- 為降低認知衰退或失智風險而管理高血壓屬條件式建議，證據確定性極低。

證據與可能效益

- 控制血壓的心血管與腦中風利益明確；對失智發生的額外直接效果仍不確定。
- 中年血壓暴露可能特別重要，但治療仍需依整體風險與個人耐受度。

限制、風險與容易誤解之處

- 一次正常讀值不代表可以停藥；量測錯誤、白袍效應與依從性都需辨識。
- 高齡者應留意直立性低血壓、頭暈、跌倒、脫水及多重用藥。

落實與追蹤方式

- 使用合適袖帶、休息後量測並重複確認；提供居家監測與用藥整理。
- 把減鹽、活動、體重、飲酒、睡眠與藥物管理整合，定期檢視不良反應。

研究缺口

- 需要釐清不同年齡、目標血壓、藥物類別及治療起始時點的長期認知效果。

原文核對：第3章 Recommendations，原文印刷頁 53–56。官方出版頁：<https://www.who.int/publications/i/item/9789240123557>

10 血脂異常

領域：健康狀況

建議：條件式建議

證據：低

原文：57–59

WHO失智特定建議

可在中年期提供血脂異常管理，以降低認知衰退及／或失智風險。

醫療人員版行動重點

依風險分層治療；清楚說明失智風險證據與心血管適應症不是同一層級。

原版摘要如何解讀

建議特別標示『中年期』。治療仍應以整體心血管風險與既有臨床指引為主。

WHO通用指引與適用範圍

- 所有血脂異常成人都應依整體心血管風險及既有指引接受管理。
- 失智特定建議只明確針對中年期血脂異常管理，屬條件式建議、低確定性。

證據與可能效益

- 中年血脂異常可能與後續認知衰退及失智風險相關，但直接介入證據有限。
- 降脂治療的心血管適應症與失智預防的證據層級不同，不能互相取代。

限制、風險與容易誤解之處

- 不應因網路上對認知副作用的片段訊息自行停用降脂藥。
- 應評估肌肉症狀、交互作用、依從性及個人心血管風險。

落實與追蹤方式

- 以共享決策說明治療主要目標，搭配飲食、活動、戒菸及血壓糖尿病管理。
- 定期追蹤血脂、症狀與用藥，必要時調整而非直接中止。

研究缺口

- 需要更多從中年追蹤到晚年的試驗與觀察研究，並比較不同降脂策略的認知結果。

原文核對：第3章 Recommendations，原文印刷頁 57–59。官方出版頁：<https://www.who.int/publications/i/item/9789240123557>

11 聽力損失

領域：感官與生命階段

建議：條件式建議

證據：低

原文：60–63

WHO失智特定建議

可向有聽力損失的成人提供助聽器，以降低認知衰退及／或失智風險。

醫療人員版行動重點

建立篩檢—聽力學評估—選配—復健—追蹤路徑，處理耳垢等可逆原因。

原版摘要如何解讀

助聽照護不只是配戴設備，還包含篩檢、驗配、適應、維護與溝通環境。可近性與費用是重要公平議題。

WHO通用指引與適用範圍

- 聽力損失的預防、篩檢、診斷、復健與持續管理都應依 WHO 指引提供。
- 對有聽力損失成人提供助聽器是條件式建議、低確定性；不是對所有人例行配戴。

證據與可能效益

- 改善聽力可能支持溝通、社交參與及認知測驗表現，並可能降低認知衰退風險。
- 助聽照護的效果取決於合適驗配、適應訓練、維護與持續使用，不只是取得設備。

限制、風險與容易誤解之處

- 先排除耳垢、感染或其他可處理原因；未經評估自行購買設備可能不合適。
- 費用、維修、污名、手部操作、認知與數位能力會影響實際使用。

落實與追蹤方式

- 建立篩檢、聽力學評估、選配、復健與追蹤路徑；同時改善說話方式、照明及背景噪音。
- 定期檢查電池、耳模、舒適度與使用時數，並讓家屬及照護者學習有效溝通。

研究缺口

- 需要更長期失智結果、不同聽力損失程度及資源有限地區的可近性與成本效益研究。

原文核對：第3章 Recommendations，原文印刷頁 60–63。官方出版頁：<https://www.who.int/publications/i/item/9789240123557>

12 更年期荷爾蒙治療

領域：感官與生命階段

建議：反對建議／證據不足

證據：極低

原文：64–67

WHO失智特定建議

不應為降低認知衰退或失智風險而對65歲以上停經者使用更年期荷爾蒙治療；65歲以下證據不足，無法提出失智特定建議。

醫療人員版行動重點

區分失智預防與症狀治療適應症；65歲以上不可為認知預防而啟動。

原版摘要如何解讀

這不等同於否定荷爾蒙治療對其他核准症狀的用途。目的、開始年齡、配方與個人風險都重要。

WHO通用指引與適用範圍

- 更年期荷爾蒙治療主要用於血管舒縮症狀與泌尿生殖更年期症候群，不是失智預防藥物。
- 65歲以上停經者不建議為降低認知衰退或失智風險而使用；這是條件式反對建議、證據極低。

證據與可能效益

- 65歲以下，包括卵巢早衰、提早停經或更年期過渡期，目前不足以針對失智預防提出支持或反對建議。
- 年齡、開始治療時間、配方、給藥途徑與個人風險可能影響結果。

限制、風險與容易誤解之處

- 反對的是以失智預防為目的啟動治療，不等於否定其他核准症狀的適應症。
- 既有使用者不應自行停藥，需與開方醫師檢視治療目的及個別利益風險。

落實與追蹤方式

- 衛教時明確區分症狀治療與失智預防，記錄年齡、停經狀態、適應症及治療開始時間。
- 依更年期照護指引進行共享決策，不以認知保護作為宣傳訴求。

研究缺口

- 需要依年齡、停經時點、配方與療程分層的長期研究，特別是65歲以下族群。

原文核對：第3章 Recommendations，原文印刷頁 64–67。官方出版頁：<https://www.who.int/publications/i/item/9789240123557>

13 憂鬱症

領域：需依既有指引

建議：證據不足

證據：—

原文：68–71

WHO失智特定建議

目前沒有足夠證據提出『治療憂鬱症以降低失智風險』的特定建議；憂鬱症仍應依WHO及在地指引辨識與治療。

醫療人員版行動重點

完成鑑別診斷與風險評估，依憂鬱治療指引處置；避免承諾可預防失智。

原版摘要如何解讀

證據不足不是『不用處理』。憂鬱本身造成痛苦、失能與自殺風險，也可能與認知表現互相影響。

WHO通用指引與適用範圍

- 所有憂鬱症成人仍應依 mhGAP 或所在地指引接受心理治療、抗憂鬱藥物或其他適當照護。
- 目前只是無法建議『治療憂鬱以預防失智』，不是無法建議治療憂鬱症本身。

證據與可能效益

- 憂鬱與認知表現、功能、睡眠及健康行為彼此影響，也可能是失智前驅或共同風險表現。
- 現有研究不足以證明某種憂鬱治療可降低日後MCI或失智發生。

限制、風險與容易誤解之處

- 需評估自傷、自殺、躁期、物質使用、藥物與身體疾病；危機風險優先處理。
- 高齡者憂鬱可能表現為記憶抱怨、退縮或身體症狀，不能只靠單一量表判斷。

落實與追蹤方式

- 使用標準化評估並持續追蹤症狀、功能與安全；將心理、社會及藥物介入個別化。
- 若認知問題在情緒改善後仍持續或惡化，再進一步進行認知評估。

研究缺口

- 需要以失智發生為結局、區分生命階段與憂鬱亞型的長期治療研究。

原文核對：第3章 Recommendations，原文印刷頁 68–71。官方出版頁：<https://www.who.int/publications/i/item/9789240123557>

14 中風

領域：需依既有指引

建議：證據不足

證據：—

原文：72-75

WHO失智特定建議

目前不足以提出中風管理可降低失智風險的特定建議；中風急性治療、復健與二級預防仍不可延誤。

醫療人員版行動重點

依中風路徑處理並納入認知篩檢、情緒、功能及血管危險因子。

原版摘要如何解讀

中風後認知障礙常見，但介入對長期失智結局的直接證據不足。

WHO通用指引與適用範圍

- 所有疑似中風者都應立即接受急性處置；中風後應提供復健、二級預防與心腦血管風險管理。
- 目前不足以建議常用預防再中風藥物可專門降低認知衰退或失智風險。

證據與可能效益

- 中風後認知障礙常見，且可能受病灶、復發、血管風險、情緒與功能限制共同影響。
- 二級預防可降低再中風及其他血管事件，但對長期失智發生的直接證據不足。

限制、風險與容易誤解之處

- 證據不足不能成為延誤抗栓、血壓、血脂、心房顫動處理或復健的理由。
- 突然臉歪、單側無力、語言困難、視力或平衡異常應立即啟動緊急醫療。

落實與追蹤方式

- 把認知、情緒、吞嚥、溝通、活動與日常功能納入中風後評估及轉介。
- 支持規律用藥、復健、危險因子管理及照護者教育，並監測復發警訊。

研究缺口

- 需要把認知及失智設為中風試驗的長期核心結局，並評估不同病型與復發預防策略。

原文核對：第3章 Recommendations，原文印刷頁 72-75。官方出版頁：<https://www.who.int/publications/i/item/9789240123557>

15 創傷性腦損傷

領域：需依既有指引

建議：證據不足

證據：—

原文：76–79

WHO失智特定建議

目前不足以提出TBI管理可降低失智風險的特定建議；頭部外傷的預防與急慢性照護仍重要。

醫療人員版行動重點

依TBI指引評估與復健；對反覆受傷者提供風險降低諮詢。

原版摘要如何解讀

受傷嚴重度、次數與時間差異大；避免跌倒、交通與職業傷害是合理公共衛生措施。

WHO通用指引與適用範圍

- 應落實道路安全、頭盔、職業安全、運動腦震盪管理、跌倒預防及暴力預防。
- 目前不足以建議腦外傷後某種特定介入可專門降低未來認知衰退或失智風險。

證據與可能效益

- 風險可能受到受傷嚴重度、次數、年齡、意識喪失與共病影響，研究定義差異很大。
- 預防傷害、急性評估及復健本身仍有明確臨床與公共衛生價值。

限制、風險與容易誤解之處

- 惡化頭痛、反覆嘔吐、嗜睡、抽搐、意識或神經功能改變需立即就醫。
- 運動或工作後不能只以症狀暫時改善判定安全回場。

落實與追蹤方式

- 記錄受傷次數、嚴重度與恢復情況，依指引安排影像、觀察、復健及分階段回到活動。
- 長照與社區場域強化跌倒風險、環境、輔具、藥物及視聽功能評估。

研究缺口

- 需要標準化TBI定義、累積暴露與長期追蹤，並比較預防及復健策略的認知結果。

原文核對：第3章 Recommendations，原文印刷頁 76–79。官方出版頁：<https://www.who.int/publications/i/item/9789240123557>

16 視力障礙

領域：需依既有指引

建議：證據不足

證據：—

原文：80–82

WHO失智特定建議

目前不足以提出視力障礙管理可降低失智風險的特定建議；可避免的視損仍應篩檢與治療。

醫療人員版行動重點

治療白內障、屈光不正等可處理原因；解讀認知測驗時考量視覺需求。

原版摘要如何解讀

視力會影響活動、跌倒、社交與認知測驗表現；感官障礙也可能造成誤判。

WHO通用指引與適用範圍

- 所有疑似視力障礙成人都應接受篩檢，確診者應依眼科與復健指引處理。
- 目前不足以建議視力介入可專門降低認知衰退或失智風險。

證據與可能效益

- 視力影響活動、跌倒、社會參與、生活品質及認知測驗表現；改善視力仍具多重健康利益。
- 現有研究尚不足以確認白內障手術、眼鏡或其他介入對失智發生的直接效果。

限制、風險與容易誤解之處

- 認知測驗未調整視覺需求可能低估能力；感官障礙不應直接被誤認為認知退化。
- 突然視力喪失、眼痛或神經症狀需要緊急評估。

落實與追蹤方式

- 處理屈光不正、白內障及其他可治療原因，並改善照明、對比、標示與環境動線。
- 確保眼鏡度數、清潔與配戴合適；認知活動及衛教資料需提供可閱讀格式。

研究缺口

- 需要更嚴謹的長期介入研究，並區分不同視力障礙原因、嚴重度及治療方式。

原文核對：第3章 Recommendations，原文印刷頁 80–82。官方出版頁：<https://www.who.int/publications/i/item/9789240123557>

17 睡眠

領域：需依既有指引

建議：證據不足

證據：—

原文：83–86

WHO失智特定建議

目前不足以提出睡眠介入可降低失智風險的特定建議；失眠、阻塞型睡眠呼吸中止等仍應依臨床需要處理。

醫療人員版行動重點

鑑別OSA、失眠、情緒、疼痛與藥物因素；依相應指引治療。

原版摘要如何解讀

睡眠與認知具雙向關係，研究介入與結局不一致。不要將『證據不足』解讀成可以忽略睡眠疾病。

WHO通用指引與適用範圍

- 良好睡眠包括足夠時數、連續不中斷及具恢復性的深睡眠，對整體健康與福祉很重要。
- 目前對治療睡眠—清醒障礙或單純改善睡眠品質／時數，都不足以提出失智預防特定建議。

證據與可能效益

- 睡眠與認知可能是雙向關係；睡眠改變也可能是其他疾病、藥物或早期神經退化表現。
- 現有試驗種類、睡眠測量與認知結局差異大，缺少長期失智發生資料。

限制、風險與容易誤解之處

- 證據不足不代表忽略失眠、阻塞型睡眠呼吸中止、日間嗜睡或其他睡眠疾病。
- 安眠藥可能增加跌倒、混亂與依賴風險，需依個人情況評估。

落實與追蹤方式

- 先評估作息、打鼾與呼吸暫停、疼痛、情緒、物質、藥物及夜間環境，再依診斷治療。
- 記錄睡眠與白天功能，優先採用適當的非藥物與疾病特定介入。

研究缺口

- 需要客觀睡眠測量、不同睡眠障礙分層及以MCI／失智為結局的長期試驗。

原文核對：第3章 Recommendations，原文印刷頁 83–86。官方出版頁：<https://www.who.int/publications/i/item/9789240123557>

18 HIV

領域：需依既有指引

建議：證據不足

證據：—

原文：87–90

WHO失智特定建議

目前不足以提出HIV處置可降低失智風險的特定建議；HIV應早期診斷並依指引持續抗病毒治療。

醫療人員版行動重點

確認病毒控制、依從性、神經與精神共病；依HIV指引處理。

原版摘要如何解讀

認知問題可能受病毒、共病、心理社會因素與治療等共同影響；污名會阻礙照護。

WHO通用指引與適用範圍

- 所有 HIV 感染者都應不受臨床分期與CD4限制，開始並持續抗反轉錄病毒治療以達到病毒抑制。
- 目前不足以為失智預防推薦某一種 ART 組合優於另一種；應依疾病控制、耐受性與偏好選擇。

證據與可能效益

- 認知問題可能同時受到病毒控制、過去中樞神經傷害、共病、物質、心理健康與社會因素影響。
- 維持病毒抑制對個人健康與降低傳播具明確利益，但不同ART組合的認知優勢尚未確立。

限制、風險與容易誤解之處

- 不可因認知疑慮自行更換或中止ART；需先評估依從性、交互作用與其他原因。
- 污名、隱私與服務可近性會直接影響持續治療。

落實與追蹤方式

- 確認病毒量、用藥、神經與精神共病、功能及社會支持；必要時安排神經認知評估。
- 提供保密、無污名的整合照護，簡化治療並支持長期依從。

研究缺口

- 需要一致的HIV相關認知結局、更多女性與高齡者資料，以及不同ART與長期病毒控制研究。

原文核對：第3章 Recommendations，原文印刷頁 87–90。官方出版頁：<https://www.who.int/publications/i/item/9789240123557>

19 空氣污染

領域：環境	建議：條件式建議	證據：極低	原文：92-96
-------	----------	-------	----------

WHO失智特定建議
可考慮採取降低空氣污染暴露的介入，以降低認知衰退及／或失智風險。

醫療人員版行動重點
詢問居住、職業與燃料暴露，提供可行建議；支持跨部門與人口層級措施。

原版摘要如何解讀

個人選擇只能解決部分暴露，結構性政策、交通、能源與職業安全同樣重要。直接失智介入證據確定性極低。

WHO通用指引與適用範圍

- 空氣污染具有毒性，室內與戶外暴露都應在生命歷程中降低；主要污染物包括PM2.5、PM10、臭氧、二氧化氮、二氧化硫及一氧化碳。
- WHO 分別對降低家庭空氣污染及環境空氣污染（特別是PM2.5）提出條件式新建議，證據確定性極低。

證據與可能效益

- 觀察研究顯示較高污染暴露與認知衰退及失智發生相關，但暴露測量、混雜因子與因果推論有限。
- 降低污染同時可改善呼吸、心血管、孕產與兒童健康，公共衛生利益不只限於失智。

限制、風險與容易誤解之處

- 個人戴口罩或留在室內只能減少部分暴露，不能取代能源、交通、住宅及職業政策。
- 弱勢、低收入、特定職業與使用污染燃料家庭常承受較高暴露，不應把責任全部放在個人。

落實與追蹤方式

- 依官方空氣品質資訊調整高強度戶外活動，改善通風與烹調排煙，減少室內燃燒與菸煙。
- 醫療與照護端詢問住家、燃料、交通及職業暴露；政府端採用符合空氣品質指引的跨部門措施。

研究缺口

- 需要介入與自然實驗、個人暴露測量、低中所得國家資料，以及政策成本效益與公平性評估。

原文核對：第3章 Recommendations，原文印刷頁 92-96。官方出版頁：<https://www.who.int/publications/i/item/9789240123557>

20 多領域介入

領域：整合介入

建議：條件式建議

證據：中至高

原文：98–101

WHO失智特定建議

可向認知正常或MCI成人提供同時針對多個可改變風險因子的多領域介入，以降低認知衰退及／或失智風險。

醫療人員版行動重點

進行整合風險評估、共享決策與分層追蹤；避免單一『防失智套餐』取代個別化照護。

原版摘要如何解讀

介入通常組合飲食、運動、認知刺激與血管／代謝風險管理；內容、強度及受益者差異大，需以個人風險與可行性設計。

WHO通用指引與適用範圍

- 多個風險常同時存在並在生命歷程累積，因此應整體評估，而不是把每一項風險分開處理。
- 「量身調整」是依實際存在的可改變風險、強度、交付方式、文化、社經及資源調整；「多領域」是同時處理多個風險。

證據與可能效益

- 多領域介入常結合飲食、活動、認知刺激及血管／代謝風險管理；整體證據確定性為中等至高。
- 效果會因基線風險、介入組合、強度、依從性與追蹤期而不同，不能把單一研究套餐直接套用所有人。

限制、風險與容易誤解之處

- 同時設定太多目標可能增加負擔與不平等；需考量費用、交通、數位能力及照顧責任。
- 多領域方案不能取代個別疾病的標準治療，也不能宣稱保證預防失智。

落實與追蹤方式

- 先完成整合風險評估，再與本人選擇2至3個最重要且可行的目標，定期檢視並逐步調整。
- 以跨專業、基層醫療與社區協作提供服務，追蹤風險控制、參與、功能、生活品質及不良事件。

研究缺口

- 需要辨識最有效的介入組合、最可能受益族群、長期成本效益及可在不同資源環境擴展的模式。

原文核對：第3章 Recommendations，原文印刷頁 98–101。官方出版頁：<https://www.who.int/publications/i/item/9789240123557>

第三部分 執行、監測與未來方向

跨領域執行重點

- 以生命歷程與公平為核心：教育、環境、收入、性別、地理位置及服務可近性都會影響風險與介入成效。
- 整合基層醫療、非傳染性疾病、健康老化、長照、心理健康、感官、復健與社區服務。
- 採多部門合作處理空氣污染、交通、教育、社會連結、食物環境與職業安全。
- 平衡數位與面對面服務；數位工具需同時處理設備、網路、識能、語言、隱私與無障礙。
- 培訓工作人員使用一致訊息，避免污名、責備個人或誇大『防失智』效果。

監測與評估建議

- 輸入與流程：人力、訓練、轉介完成率、服務等待、可近性及成本。
- 參與與安全：參與率、持續性、退出原因、不良事件、跌倒、低血糖或戒斷等。
- 健康與功能：風險因子控制、日常功能、生活品質、情緒、社交與照護負擔。
- 公平性：依年齡、性別、社經、地區、障礙與族群分析是否出現服務落差。
- 長期結果：MCI、失智發生及認知軌跡；短期認知分數不能取代長期結果。

整體證據限制

- 許多主題主要依賴觀察研究或少數隨機試驗，追蹤時間短，且很少把MCI或失智發生作為結局。
- 研究多來自高所得國家，亞組分析有限，介入與結局定義不一致。
- 多個風險因子的交互作用、可行性、擴展性、成本效益及政策層級介入仍缺資料。
- 未來研究需提高低中所得國家與弱勢族群代表性，並報告公平性及不良事件。

原文定位：第4章，原文印刷頁 102-105。

資料來源與核對方式

World Health Organization. Risk reduction of cognitive decline and dementia: WHO guidelines, second edition. Geneva: World Health Organization; 2026. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. ISBN 978-92-4-012355-7.

WHO官方出版頁：<https://www.who.int/publications/i/item/9789240123557>

本手冊的原文定位以WHO文件中的章節及印刷頁碼呈現。若需查看完整證據表、effect estimates、GRADE評估與evidence-to-decision表，請由原文目錄的 Web Annex A-P 进入对应资料。

使用本手冊時請記得

- 這是詳細整理版，但仍不是逐字完整翻譯，也未重製所有研究表格與參考文獻。
- WHO文件與相關臨床指引可能更新；作出健康、照護或政策決策前應查看官方最新版本。
- 引用本中文整理時，請同時標示WHO原著、非官方改作性質、AI協作方式及授權。